

Fecha Última Actualización: 30-11-2024 13:45:09

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Sandra Bernarda Tapia Nunez
Edad : 56a 11m 15d
Dirección : Camino La Rinconada Principal 142 Si

Rut : 11.339.622-9
Fecha Nacto: 15/12/1967
Comuna : Pirque

N° Archivo : 9821018
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 7862 0193

N° Epicrisis
422470

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Ingreso : 21/11/2024 19:41

Días Estadía : 9

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 30/11/2024 13:11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

CEG

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

24/11/2024 12:34:06
H.Clausdorff
Evolución Unidad A3

Días de Hospitalización: 3
Días en UPC: 0

Diagnósticos:

1) Shock mixto

1)Distributivo

a. Sepsis Foco en estudio (Focos probables --> ITS x CVC tunelizado, SD Diarreico, Litiasis

Infectada. EBSA?)

b. Insuficiencia Suprarrenal (Usuaría Corticoides)

2) Hipovolémico

a. Fase Inicial Sepsis

2) Post - PCR

1) 2da a hipoxia --> AESP (2 ciclos)

2) ROSC a TV monomorfa, manejo médico

3) FOM

1) Circulatoria

2) Plaquetopenia

3) AKI (en contexto ERC). Oligoanuria

4) Hipoglicemia

5) Hipocalcemia

4) Antecedentes:

a) ERC etapa V en HD (Nefritis Lúpica), centro Dávita MJS 3er turno, diuresis residual 500ml, en plan de estudio de trasplante.

b) Ingreso a HD en noviembre/2024 por CHD YD°

c) LES con compromiso cutáneo y renal (nefritis lúpica IV y ATR tipo I) que recibió MTP + CFF 2015 y Rituximab 2016.

Fecha Epicrisis : 30/11/2024 13:45

Página 1 de 5

Fecha Última Actualización: 30-11-2024 13:45:09

Página 2 de 5

- d) Síndrome de Sjögren
- e) Leucoencefalopatía posterior reversible resuelta (obs 2º a Ciclofosfamida).
- f) HTA.
- g) Anemia severa

Se recibe a paciente en malas condiciones generales, con livideces hasta cuello, triple DVA (NAD 0,7ug/kg/min - Vaso 0,07UI/min + DBT 2ug/kg/min), PAM 50. Llame capilar no objetivable por livideces. Acoplada a VMI modalidad V A/C FiO2 80%. En SAS 1 Fenta + Midazolam dosis moderada. Diuresis 40cc. Depos (-)

Al ex. Físico

Fría a distal, Mottling ya descrito. Sin respuesta a estímulo bilateral

Estrías de sangre en Boca, relación a TOT

Pupilas mióticas no reactivas

Yugulares (-)

RR2TSS, MP disminuido bilateral

Abd: BDI, RHA+ Masas (-) Blumberg (-)

EEll: edema ++ TVP (-) pulsos++

Evolución por sistemas

1) HDN y CV: Paciente cursando falla circulatoria, con micro y macroperfusión alteradas. Hiperlactatemia sostenida (multifactorial entre post PCR, uso de DBT y shock concomitante). Ecocopia hoy con FS moderadamente disminuida (FEVI 40 -45%), Sin valvulopatías severas. Derrame pericárdico (-) VD no dilatado. VTI izquierdo 12 con variación >15% en relación a ciclo respiratorio. Se indica volemicización con 1000cc cristaloides, asociado a suspensión de DBT y subida de NAD a 1ug/kg7min, con repunte de PAM. Se da aviso a jefatura de UPC para plantear HFAV como manejo de shock, la cual es aceptada por jefatura y nefrología. Actualización de exámenes y planes según resultados

2) Ventilatorio: Ecocopia mostrando US pulmonar, destacando con patrón aireado, sin condensaciones y derrame pleural mínimo a izq + atelectasia pasiva pequeña en ese lado. PaFI hoy 221 con FiO2 80%. Destaca además mecánica pulmonar límite, con Pplat 24 Compliance 14. Monitorización seriada

3) Infeccioso: Cubierta de forma empírica con Imi-Vanco sin foco precisado (se toma entre 21 y 24 UC, Toxina CD, HC I y II, HC cuantitativo y de catéter y portación KPC + ERV VAN A - VAN B todas pendientes o negativas. Dado que probable foco sea C.Tunelizado, se instalará transitorio para HFAV y me comunico con cirugía de turno, quien retirará transitorio (y cultivo correspondiente). PCR alta y con febrículas. Sin cambios de ATB por el momento

4) Renal e HD: mantiene oligoanuria (orina basal 500cc) con hiponatremia leve. Plan de HFAV como ya descrito vía acceso transitorio. Sin mayores cambios. Reposición de Calcio en paralelo a

5) Nutri - Metabol: suplementación de Glucosa al 30% dado hipoglicemia constante, mantengo en cero dado altas dosis de DVA.

6) Neuro: Mantener en SAS 1 dado shock actual

7) Profilaxis: IBP como de costumbre. Sin Heparinas dado plaquetopenia.

Manejo Activo

HFAV hoy

Retiro de Tunelizado (y cultivo) + CHD transitorio

Mantener ATB

Control Exámenes PM

30/11/2024 08:40:27

E.Ossandón

FI HSR 21/11/24

FI UTIM 22/11/24

FI UCI: 24/11/24

Fecha Última Actualización: 30-11-2024 13:45:09

Página 3 de 5

Días de Hospitalización: 8

Días en UPC: 5

Diagnósticos:

1) Shock Tóxico

Infección de Catéter tunelizado ¿ SAMS (cultivo 24/11)

b. Insuficiencia Suprarrenal (Usuaría Corticoides)

2) Post - PCR

1) 2da a hipoxia --> AESP (2 ciclos)

2) ROSC a TV monomorfa, manejo médico

3) FOM

1) Circulatoria

2) Plaquetopenia

3) AKI (en contexto ERC). Oligoanuria

4) Hipoglicemia

5) Hipocalcemia

4) Sd. Purpúrico - CID

4) Antecedentes:

a) ERC etapa V en HD (Nefritis Lúpica), centro Dávita MJS 3er turno, diuresis residual 500ml, en plan de estudio de trasplante.

b) Ingreso a HD en noviembre/2024 por CHD YD°

c) LES con compromiso cutáneo y renal (nefritis lúpica IV y ATR tipo I) que recibió MTP + CFF 2015 y Rituximab 2016.

d) Síndrome de Sjögren

e) Leucoencefalopatía posterior reversible resuelta (obs 2° a Ciclofosfamida).

f) HTA.

g) Anemia severa

Paciente muy grave,

DVA altas actualmente norepinefrina 0.3 mcg/K/M

Persiste hipotensa

se conversa con jefatura modulo y nefrología , se decide dado severidad de condición de paciente con pronóstico ominoso ,suspender terapia de reemplazo renal, y establecer condición actual como techo optimizando el confort del paciente y acompañamiento familiar

se encuentra en VMI modo controlado alza de requerimientos de oxígeno

radiografía destaca tubo ET monobronquial izquierdo asociado a atelectasias LII y opacidades bilaterales

presenta hemoptisis por TET, se retira TET 3 cms

evaluado el 28.11.24 por Infectología dado cuadro de sepsis grave con lesiones cutáneas prurpuras flictenas y necrosis de extremidades.

22/11 UC E coli MS.

22/11 HC 4 día 1/2 SAMS (recibió antibioticos previo a cultivo).

Cultivo punta cateter 24/11 SAMS

Muy probablemente un TSS

Tratada con vancomicina + clindamicina hasta ayer en contexto de shock tóxico por S aureus

se decidió rotación a cloxacilina 2g ev c/4h por la cual debe mantenerse por 14 días y mantener clindamicina 900 mg c/8h ev hasta completar 7 días.

1) HDN y CV: Paciente cursando falla circulatoria, con micro y macroperfusión alteradas.

DVA en techo terapeutico definido , tendencia a hipotension

2) Ventilatorio:en modo controlado , se ha aumentado sedoanalgesia para ventilar protector y ademas confort

Fecha Epicrisis : 30/11/2024 13:45

Página 3 de 5

- 3) Infeccioso: Catéter tunelizado (+) a SAMS, HC: cocáceas gram (+) impresiona cursando Shock Tóxico, en ese marco se agrega cloxacilina + Clindamicina (día 4. Se suspende vancomicina e imipenem
- 4) Reumato: Ant. de LES, dado cuadro de purpura y trombocitopenia severa, se solicita serología para descartar Sd. Antifosfolípido. catastrófico. Equipo de Reumatología al tanto de caso.
- 4) Renal e HD: ayer se suspendió TRR por inestabilidad y dado requerimiento en techo de DVA, evaluar hoy si mantiene esa conducta
- 5) Nutri - Metabol: paciente grave, no en condiciones de inicio NPT
- 6) Neuro: Mantener en SAS 1 dado shock actual. TAC de cerebro 26 sin lesiones evidentes.
- 7) Dermato: Múltiples lesiones ampulares (no hemorrágicas) + lesiones descamativas, se manejará como gran quemado, con cobertura de apósitos estériles. Reposición de volumen restrictivo ajustado a contexto de ERC actualmente anúrica.
- 7) Profilaxis: IBP como de costumbre. Sin Heparinas dado plaquetopenia.

30/11/2024 11:11:57
H.Clausdorff
Evolución Unidad A3

Días de Hospitalización: 9
Días en UPC: 6

Diagnósticos:

- 1) Shock Tóxico (más probable stafilocócico)
Infección de Catéter tunelizado ¿ SAMS (cultivo 24/11)
b. Insuficiencia Suprarrenal (Usuaria Corticoides)
- 2) Post - PCR
 - 1) 2da a hipoxia --> AESP (2 ciclos)
 - 2) ROSC a TV monomorfa, manejo médico
- 3) FOM
 - 1) Circulatoria
 - 2) Plaquetopenia
 - 3) AKI (en contexto ERC). Oligoanuria
 - 4) Hipoglicemia
 - 5) Hipocalcemia
- 4) Sd. Purpúrico - CID
- 4) Antecedentes:
 - a) ERC etapa V en HD (Nefritis Lúpica), centro Dávita MJS 3er turno, diuresis residual 500ml, en plan de estudio de trasplante.
 - b) Ingreso a HD en noviembre/2024 por CHD YD°
 - c) LES con compromiso cutáneo y renal (nefritis lúpica IV y ATR tipo I) que recibió MTP + CFF 2015 y Rituximab 2016.

Fecha Última Actualización: 30-11-2024 13:45:09

Página 5 de 5

- d) Síndrome de Sjögren
- e) Leucoencefalopatía posterior reversible resuelta (obs 2° a Ciclofosfamida).
- f) HTA.
- g) Anemia severa

Paciente en muy malas condiciones generales, actualmente en techo terapéutico definido por jefatura de módulo (NAD 0,3ug/kg/min, no TRR, No RCP y PCR). Impresiona sostenidamente hipotensa, normocárdica, junto con compromiso cutáneo por púrpura y flictenas desde cuello. Anúrica desde hace 24 horas. Hipotérmica. Sin deposiciones

Al ex. Físico

PAM 20

Fría a distal. Flictenas de mal olor y púrpura generalizado

Yugulares (-)

RR2TSS, MP+ SRA

Abd: BD, RHA+ Masas (-) Blumberg (-)

EEl: edema (-) TVP (-) Pulsos++

Plan

- Paciente actualmente con pronóstico ominoso en manejo proporcional. En suma, cursa con FOM sin respuesta a soporte actual

- Se da aviso a familiares para acompañamiento

- Sedación

- Se mantiene TOPE, si PCR no RCP

Pronóstico Ominoso

Manejo proporcional, acompañamiento por familiares

30/11/2024 13:43:04

H.Clausdorff

Paciente fallece 13:30 acompañada por sus familiares

Extiendo certificado de defunción

Diagnóstico de Egreso

Shock séptico -

Shock séptico -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecida 30/11/24 13:30 hrs

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Fecha Epicrisis : 30/11/2024 13:45

Becado/Residente

Hans Clausdorff Fiedler

Médico Tratante (Staff)

Página 5 de 5